一页临床路径｜视网膜静脉阻塞｜三源整合

中国共识解读 2024 ｜ SEMI/SERV 意见 2025 • 条件与下一步按原文整理；诊断细则和特殊分支见提取表

1 确诊分型＋同步基线评估

区分 CRVO/BRVO； HRVO 按西意见说明。查视力、眼前后节、 OCT 与灌注；病因筛查同步，不延误眼部处理。

中① 2024 p187；中② 2024 p265；西 2025 PDF2–6

并发症筛查

2 有新生血管或 NVG？

查虹膜、房角及眼底。中①：病程 >2 个月强调房角镜。已发现新生血管 /NVG→3；无→ 4 。

中① 2024 p187；中② 2024 p265

有新生血管 /NVG

3 优先处理新生血管并发症

按情境联合抗 VEGF 、相应激光 /PRP 及降眼压治疗。不能以抗 VEGF 替代应做的激光；控制后→ 6 。

中① 2024 p188；中② 2024 p265–266；西 2025 PDF6

4 有影响视功能的黄斑水肿?

明显视功能损伤→ 5；视功能尚好可个体观察→ 6 。统一视力 /CMT 切点未明确； 0.5 不是通用启动阈值。

中② 2024 p265–266

视功能受损 ME

控制后随访

5 抗 VEGF 为主，按反应调整

中①：每月 1 次 ×3 次后按需；反应差且无激素禁忌，可考虑激素二线。复评病因、缺血及眼压后→6 。

中① 2024 p187–188；中② 2024 p265；西 2025 PDF6

复评并随访

6 持续随访＋全身协同管理

中①随访至少 2 年；西：缺血 CRVO 每月。活动性 ME 按治疗复评。新生血管或 ME 复发返回 2/4；抗栓见特定来源。

中① 2024 p187–188；西 2025 PDF6–8

跨行分支： 2→4 无上述并发症； 4→6 可观察者

节点内条件优先；未列阈值不补编。完整证据、禁忌与特殊人群见提取表。